HLB、新薬を越えてグローバル製薬･バイオ企業に

2026.10.15

グローバル企業への跳躍

BECOMING A GLOBAL PHARMA

韓国初のFDA直接許可抗がん新薬、グローバル製薬·バイオ企業への跳躍

2030 VISION

グローバル100台
製薬·バイオ企業の跳躍

抗がん新薬を保有するグローバル企業

01 **Lyrfigtu価値拡張**
腫瘍を問わず臨床進行とヨーロッパなどグローバル市場拡大

02 **肝臓がん新薬承認後、市場拡大**
共通営業網基盤の商業化シナジー本格化

03 **グローバル協業·共同開発**
許可抗がん剤基盤の協力

04 **新規抗がんパイプラインの発掘·確保**
臨床データが確保された候補物質中心の導入検討

HLB 連結 基準 核心 パイプライン

PIPELINE OVERVIEW

子会社	パイプライン	ターゲット適応症	現在の開発段階	目標マイルストーン
elevar therapeutics	**Lyrfigtu™ (胆管癌)**	**FGFR2融合·再熱胆管癌**	**FDA承認; EMA MAA 審査中**	**「264Q米国発売目標」**
elevar therapeutics	**リボセラニブ + カムレリズマブ**	切除不能な肝細胞癌	10/9 再申請完了	NDA/BLA共同再申請
elevar therapeutics	**Lyrfigtu (腫瘍を問わない)**	FGFR2 融合/再配列 固形癌	ReFocus 202グローバル臨床2相	癌腫を問わず適応症を拡大するためのFDA sNDA提出
IMMUNOMIC THERAPEUTICS AN HLB COMPANY	**ITI-5000 (免疫抗がんワクチン)**	三重陰性乳がん(TNBC)	臨床1相進行中	安全性·耐薬性の結果確保
IMMUNOMIC THERAPEUTICS AN HLB COMPANY	**ITI-9001 (免疫治療ワクチン)**	スギ花粉症 免疫疾患	臨床1相進行中	安全性·耐薬性の結果確保

安全性·有効性データ

化学療法または化学療法と免疫関門抑制剤併用療法の治療履歴があるFGFR2融合/再配列進行性/転移性胆管癌(CCA)患者対象の安全性および有効性データ

客観的反応率(ORR)

46%

53/116人 (CR 3人 + PR 50人)

反応持続期間(mDOR)

11.8カ月

中央値 (IRC評価基準)

疾病統制率(DCR)

96.6%

中間分析基準 (n=116)

FGFR2 高選択性

FGFR2を選択的に標的にし、他のFGFRへの影響を最小化

FGFR2標的
精密標的
→
高選択性
FGFR1比250倍
FGFR4比5000倍
→
標的外毒性の減少
FGFR1·FGFR4媒介

二次耐性変異の克服

耐性変異が発生しても抑制活性を維持

前のFGFR阻害剤
治療進行中
→
耐性変異発生
V564F・V564L
N549D 等
→
Lyrfigtu™
抑制活性の維持

Pivotal臨床プログラム別の主な結果

NEW TREATMENT OPTION | elevar therapeutics

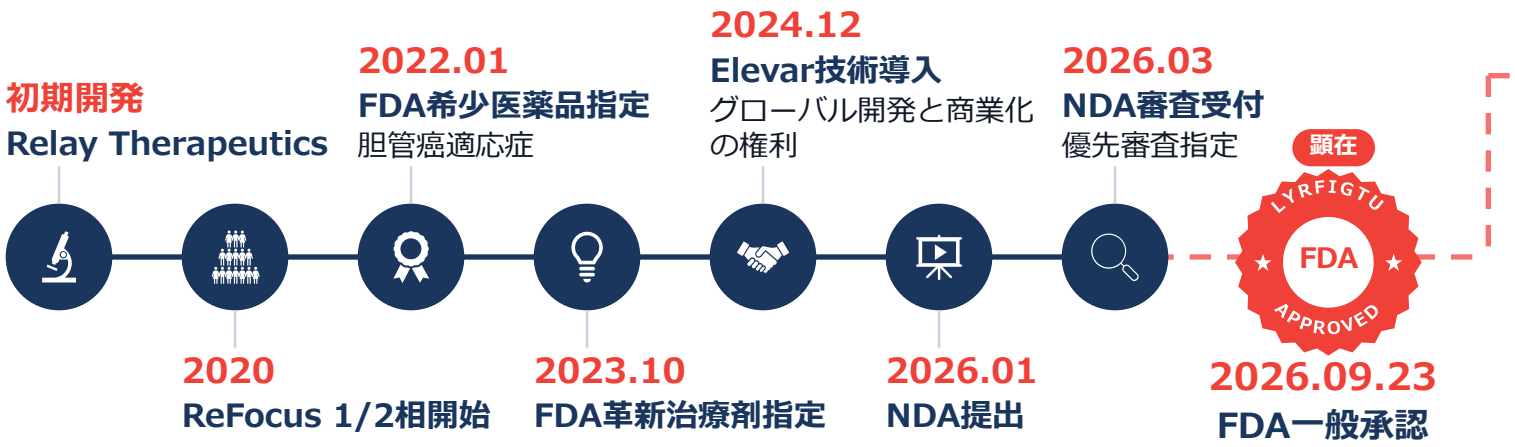
免疫関門抑制剤併用の有無にかかわらず化学療法治療履歴があるFGFR2融合/再配列陽性進行性/転移性胆管癌(CCA)のための新しい**治療オプション**

薬物	ORR 客観的反応率	DCR 疾病管理率	mOS 月月	mPFS 月月	mDOR 月月	3等級 以上 TEAE	投与中断率
リラプグラチニブ 不可逆的なFGFR2阻害剤	**46%** (n=116)	**96.6%** (n=116)	**22.8**	**11.3**	**11.8**	**62.9%** 主な:手足症候群(PPES)20%、口内炎12.2%、貧血8.3%	**5%**
フェミガチニブ 可逆的FGFR1-3阻害剤	**36%**	**82%**	**17.5**	**7.0**	**9.1**	**68.7%** 主要: 低リン酸血症 14.3%、口内炎 6.8%、関節痛 6.1%	**9%**
フチバチニブ 不可逆的FGFR1-4阻害剤	**42%**	**83%**	**21.7**	**9.0**	**9.7**	**77%** 主な:高リン酸血症30%、低ナトリウム血症11%、AST増加10%、疲労8%、口内炎6%	**4.9%**

* **参考文献**:[1] [R]eFocus 研究社内資料(Data on file)、リラプグラチニブ FDA 処方情報; [2] Vogel et al. ESMO Open. 2024 Jun; 9(6): 103488; [3] フェミガチニブ FDA 処方情報。
患者の特性、研究設計、評価時点およびその他の要因に差がある可能性があるため、数値結果の比較時に注意が必要です。

開発の経過と今後の計画

新規抗がん剤のFDA正式承認を独自に引き出した初の韓国製薬バイオグループ



アメリカ市場 DIRECT LAUNCH

- 直接販売推進
- 2026年第4四半期発売

欧州·グローバル市場 partnership model

- EMA MAA 本審査に着手
- グローバル市場への進出及び適応症の拡大

研究開発 | 権利導入及びFDA許可 | 商業化戦略

市場参入と成長潜在力

臨床的に意味のある胆管がんの臨床データを基に、迅速な市場参入、がん種の拡張及びグローバル共同開発の機会拡大を推進

01 胆管癌市場進入

2025年胆管癌競争薬物の売上構成

約2,030億ウォン

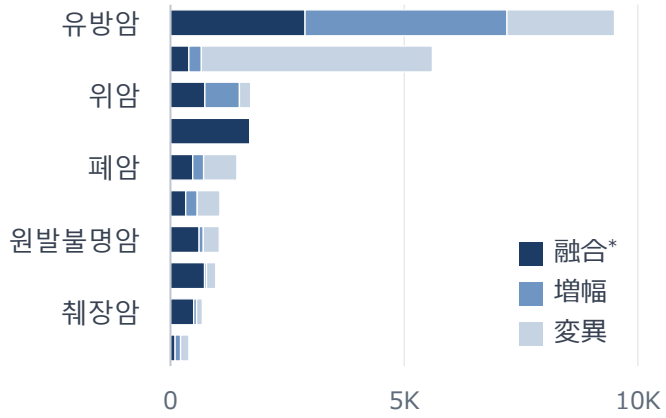


臨床的に意味のある有効性/安全性による市場参入および処方拡大

02 FGFR2 固形癌 拡張

FGFR2変異固形癌の米国推定患者数

約1.1万~3.5万人



FGFR2融合·再配列拡張臨床2相における腫瘍不問の可能性評価

03 グローバル協業拡大

リラプグラチニブ追加臨床開発

FGFR2融合/再配列
非胆管癌固形癌対象腫瘍不問研究進行中 (ELE-4008-202)

商業化の機会拡大

より広い固形癌治療市場への商業化拡大

共同開発など多様な協力

グローバル製薬会社との協力機会の模索

グローバル製薬会社との共同開発及び協業パイプライン価値の拡張

参考文献: 1. 第三者産業データ基盤内部分析、グローバルデータ(2025)、* FGFR2融合推定値はdel18切断(truncation)変異を含む

腫瘍不問適応症拡張のためのELE-4008-202

ASCO 2026で発表した抗腫瘍活性を基に、追加患者と癌種別データを確保する拡張臨床2相を進行中

予備分析

ORR 33.3%

95% CI 19.6–49.5 · 70 mg QD

FGFR2融合/再配置 非胆管癌 46人

›

ELE-4008-202

拡張グローバル臨床2相

既存バスケット研究の拡張

追加患者募集·既存46名との統合分析

›

臨床終了目標·Tumor-agnostic

暗種仏門拡張

FGFR2以上固形癌全般に

ELE-4008-202 臨床日程



切除不能な肝細胞癌対象のPivotal臨床結果

カムレリズマブ+リボセラニブ:現在までグローバル臨床3相の中で最長mOS記録

併用療法	OS	PFS	安全性 TRAEによる投与中断率	5等級 TRAE
カムレリズマブ + リボセラニブ PD-1 抑制剤 + VEGF 1-3 抑制剤	**23.8カ月** 95% CI 20.6–27.2 HR 0.64 (0.52–0.79)	**5.6か月** 95% CI 5.5–7.4 HR 0.54 (0.44–0.67)	**4.4%** 両薬物とも	**0.4%** 272人に1人
アテゾリズマブ + ベバシズマブ PD-L1 抑制剤 + VEGF 抑制剤	**19.2カ月** 95% CI 17.0–23.7 · P<.001 HR 0.66 (0.52–0.85)	**6.9カ月** 95% CI 5.7–8.6 · P<.001 HR 0.65 (0.53–0.81)	**7%** 両薬物とも	**1.5%** 336人中5人
トレメリムマブ+ザ·バルマブ PD-L1 抑制剤 + CTLA-4 抑制剤	**16.4カ月** 95% CI 14.16–19.58 · P=.0035 HR 0.78 (0.65–0.93)	**3.8カ月** 有意な差なし HR 0.90 (0.77–1.05)	**13.7%**	**2.3%** 393人中9人
イフィリムマブ+ニボルマブ CTLA-4 抑制剤 + PD-1 抑制剤	**23.7カ月** 95% CI 18.8–29.4 · P=.018 HR 0.79 (0.65–0.96)	**9.1ヶ月** PFS は探索的評価変数	**18%**	**3.6%** 332人中12人

2022;1(8):doi:10.1056/EVIDoa21000705. Yau T, et al. *Lancet* 2025;405(10492):P1851-1864.
Abs 4110.

アテゾリズマブ – ベバシズマブ、ザバルマブ – トレメリムマブ、イフィリムマブ – ニボルマブは、臨床試験でカムレリズマブ – リボセラニブと直接比較されたことはありません。

ITI免疫プラットフォームの開発

ITI IMMUNOTHERAPY PLATFORM | IMMUNOMIC THERAPEUTICS AN HLB COMPANY

独自開発UNITEワクチンプラットフォームと自己増幅RNA(saRNA)を結合して抗原特異免疫反応誘導、抗がん·アレルギー治療ワクチン開発

UNITEプラットフォーム

抗原を免疫細胞に効果的に伝達し、CD4+·CD8+T細胞を同時に活性化する免疫治療ワクチンプラットフォーム

STEP1 体内でがん抗原生産
RNAが細胞内で増幅、抗原生成

STEP2 免疫細胞に標的伝達
UNITEが抗原伝達、CD4+T細胞活性

STEP3 がん細胞の除去
CD8+キラーT細胞·抗体がガン細胞を攻撃

ITI免疫プラットフォーム臨床拡大 saRNA·UNITE技術基盤抗がん·アレルギーワクチン開発

三重陰性乳がん治療ワクチン

ITI-5000

臨床1相、初投薬完了

モデナの事例からみた抗がんワクチンの可能性
既存の免疫抗がん剤と併用して治療効果を改善
市場規模 約9,380億ウォン (2024年)

スギ花粉症ワクチン

ITI-9001

臨床1相、初投薬完了

免疫疾患への適用領域の拡大
原因抗原に対する免疫調節可能性評価
市場規模 約5,406億ウォン (2025年)



リピクトゥFDA承認

挑戦が実った今日

FDAの承認はまだ始まりに過ぎません

グローバル製薬·バイオ企業へのHLB

19年の挑戦、国内初の成果で

長い間、共に信じて待ってくださった株主の皆様と共に
韓国企業としては初めて抗がん新薬のFDA許可を直接主導し、承認を成し遂げました。

僕たちが準備してきたその次

一度の承認を超え、持続的な成果を創出するグローバル製薬·バイオ企業へと飛躍します。

THANK YOU

Human Life Betterへの旅路、HLB WAYは続きます。